

LETSELSCHADE · IWMD 2025 · FICTIEF VOORBEELD

Orthopedische expertise letselschade

Vraagstelling volgens IWMD 2025

ZAAKNUMMER

2024-KME-01583

BETROKKENE

PERSOON-1

SPECIALISME

Orthopedisch

ONDERZOEK

T+29m

FICTIEF VOORBEELD · GEEN PERSOONSgegevens

KINETICMEDICAL.NL

DIAGNOSE (ORTHOPEDISCH)

Chronische nekklachten met uitstraling naar de linker arm na een whiplashtrauma, bij pre-existente degeneratie C5–C6

RELATIE MET HET ONGEVAL Verenigbaar met aggravatie Van bestaande degeneratie C5–C6; bijdrage ongeval niet kwantificeerbaar	EINDSITUATIE Stationair Voor de nekklachten; neurologisch deel nog niet	BEPERKINGEN Matig Statische nekbelasting, bovenhands werk	AANVULLEND NODIG Neurologie Ulnarisklachten en cognitieve klachten
FUNCTIEVERLIES (AMA) 3% Gehele persoon, AMA Guides 6e druk; niet gelijk aan arbeidsongeschiktheid	DOSSIER 11 van 14 stukken 3 hiaten, 3 aandachtspunten		

AANGELEVERDE STUKKEN

11 van 14 stukken aanwezig

SEH-verslag met CT	Huisartsbrief	Huisartsjournaal	Keuringsrapport werkgever	Fysiotherapie intake
MRI cervicaal	Verwijsbrief pijnrevalidatie	EMG-verslag	Operatieverslag denervatie	Brief neurologie
Intake CGT	Fysiotherapie eindverslag ONTBREEKT	Intake en voortgang pijnrevalidatie ONTBREEKT	Neuropsychologisch onderzoek ONTBREEKT	



Gegevens opdrachtgever en betrokkene

DOSSIERORDENING

Opdrachtgever

OPDRACHTGEVER

Advocaat betrokkene

PERSOON-9, ORGANISATIE-3

Betrokkene

PERSOON-1

Geboortedatum

GEBOORTEDATUM

Ongeval

T±0: kop-staartbotsing als bestuurder

Datum onderzoek

T+29m

Specialisme

Orthopedie

Kader van dit rapport

DOSSIERORDENING

Soort expertise

Letselschade: een ander is aansprakelijk voor het ongeval

Kernvraag

Wat is het verschil tussen de situatie met en zonder ongeval?

Doel van de uitkomst

Basis voor de berekening van de schadevergoeding door partijen

Partijen

Benadeelde en de verzekeraar van de aansprakelijke partij; bij voorkeur een gezamenlijke opdracht

Vraagstelling

IWMD 2025 (De Letselschade Raad)

Invaliditeitspercentage

Optioneel, vraag 1(l)

Richtlijn rapportage

NVMSR 2024

Vraagstelling

DOSSIERORDENING

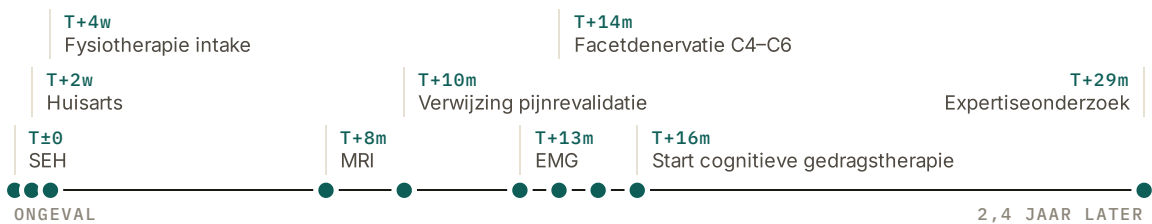
De opdrachtgever hanteert de IWMD-vraagstelling Causaal Verband bij Ongeval 2025. Deel 1 betreft de situatie met ongeval, deel 2 de situatie zonder ongeval en deel 3 overige opmerkingen. De vragen worden beantwoord voor het orthopedisch vakgebied; vraag 1(l) (functieverlies) is optioneel en door de opdrachtgever gevraagd.

BRON

Opdrachtbrief OPDRACHTGEVER

Samenvatting medische informatie

DOSSIERORDENING



- T±0 ○ SEH: WAD graad II; CT-cervicaal zonder fractuur, spondylose C5–C6 (bron 1, p. 2)
- T+2w ○ Huisarts: nekpijn met uitstraling naar de linker arm, verwijzing fysiotherapie (bron 2, p. 1)
- T+4w ○ Fysiotherapie intake: flexie 35°, extensie 25° (bron 5, p. 3)
- T+8m ○ MRI: discusdegeneratie C5–C6 met protrusie en foraminastenose links (bron 6, p. 1)
- T+10m ○ Verwijzing pijnrevalidatie (bron 7, p. 1)
- T+13m ○ EMG: geleidingsvertraging n. ulnaris ter hoogte van de linker elleboog, oorzaak niet te duiden (bron 8, p. 2)
- T+14m ○ Facetdenervatie C4–C6 (bron 9, p. 1)
- T+15m ○ Neuroloog: cervicobrachialgie links, ulnarisneuropathie, verdenking post-commotioneel syndroom (bron 10, p. 1–2)
- T+16m ○ Start cognitieve gedragstherapie (bron 11, p. 1)
- T+29m ○ Expertiseonderzoek

BRON Bronnen 1, 2, 5–11

Hiaten in het dossier

DOSSIERORDENING

Fysiotherapie eindverslag

BELANGRIJK

Intake aanwezig (bron 5), maar geen afsluitend verslag. Het resultaat van de behandeling is niet vast te stellen.

VERWACHT T+4m · ACTIE Opgevraagd bij ORGANISATIE-6 ; niet ontvangen. De conclusies in 1f houden hier rekening mee.

Intake en voortgang pijnrevalidatie

BELANGRIJK

Verwijzing aanwezig (bron 7), maar geen intake of behandelplan.

VERWACHT T+11m · ACTIE Opgevraagd bij ORGANISATIE-7 ; niet ontvangen. Niet bepalend voor de conclusies.

Neuropsychologisch onderzoek

BELANGRIJK

De neuroloog noemt een verdenking op een post-commotioneel syndroom (bron 10); een neuropsychologisch onderzoek ontbreekt.

VERWACHT T+15–24m · ACTIE Buiten het orthopedisch vakgebied; zie het advies in 3a.

Medische aandachtspunten en onzekerheden

DOSSIERORDENING

Cervicale afwijkingen: bestaand of door het ongeval?

KRITIEK

CT T±0: spondylose C5–C6 (bron 1, p. 2)

MRI T+8m: protrusie en foraminastenose links C5–C6 (bron 6, p. 1)

Neuroloog T+15m: cervicobrachialgie, 'traumatisch geaggraveerd' (bron 10, p. 2)

VOOR DE SPECIALIST De bronnen spreken elkaar niet tegen over de afwijking, maar wel over de betekenis ervan.

Ulnarisneuropathie: door het ongeval of niet?

BELANGRIJK

EMG T+13m: oorzaak niet te duiden (bron 8, p. 2)

Neuroloog T+15m: 'posttraumatisch' (bron 10, p. 2)

VOOR DE SPECIALIST Valt buiten het orthopedisch vakgebied.

Cognitieve klachten

AANDACHT

Neuroloog T+15m: verdenking post-commotioneel syndroom (bron 10, p. 2)

Neuropsychologisch onderzoek ontbreekt

VOOR DE SPECIALIST Valt buiten het orthopedisch vakgebied.

1a Anamnese

● SPECIALIST

Het relaas van betrokkene, zonder dossierinformatie.

Ongeval en beloop volgens betrokkene

Betrokkene vertelt dat hij stilstond en van achteren werd aangereden. Hij had direct pijn in de nek en hoofdpijn. In de weken daarna kreeg hij pijn die uitstraalde naar de linker schouder en arm. Fysiotherapie en een behandeling met 'verhitting van de zenuwtakjes' in de nek hielpen volgens hem kort.

Huidige klachten

Dagelijks nekpijn, links meer dan rechts, erger na beeldschermwerk en autorijden. Tintelingen in de pink en ringvinger links. Hoofdpijn enkele keren per week. Moeite met concentratie.

Werk, huishouden en vrije tijd

Hij werkt als werkvoorbereider ongeveer 60% van zijn oude uren. Na een uur beeldschermwerk moet hij pauzeren. Klussen boven het hoofd laat hij over. Hardlopen heeft hij vervangen door wandelen.

1b Medische gegevens

● SPECIALIST

Voorgeschiedenis en behandeling op basis van het medisch dossier.

Voorgeschiedenis

In de huisartsinformatie over de vijf jaar vóór het ongeval zijn geen nek- of schouderklachten gedocumenteerd. Op T-3j bezocht betrokkene de huisarts voor spanningshoofdpijn. Bij een keuring op T-19m was hij volledig arbeidsgeschikt.

UIT HET DOSSIER

Bron 3, p. 1-3; bron 4, p. 1.

Behandeling na het ongeval

Fysiotherapie vanaf T+4w, verwijzing naar pijnrevalidatie op T+10m, facetdenervatie C4-C6 op T+14m en cognitieve gedragstherapie vanaf T+16m.

UIT HET DOSSIER

Bronnen 5, 7, 9 en 11. Het eindverslag van de fysiotherapie en de gegevens van de pijnrevalidatie ontbreken.

1c Medisch onderzoek

● SPECIALIST

Bevindingen bij lichamelijk onderzoek en hulponderzoek.

Algemeen

Verzorgde man, 182 cm, 84 kg. Wisselt tijdens het gesprek regelmatig van houding.

Cervicale wervelkolom

Geen standsafwijking. Drukpijn paravertebraal C4–C6 links met verhoogde spierspanning van de m. trapezius links. Eindstandige pijn bij extensie en rotatie naar links. Bewegingsuitslagen in de tabel hieronder.

Neurologisch, oriënterend

Kracht symmetrisch, reflexen symmetrisch. Spurling links positief met uitstraling naar de schouder, rechts negatief. Verminderd gevoel aan de radiale zijde van de linker onderarm en aan de pink en ringvinger links. Voor de duiding van de ulnarisklachten verwijs ik naar de neuroloog.

Hulponderzoek

Ik heb de beelden van de MRI van T+8m zelf bekeken; de bevindingen komen overeen met het verslag. Er is geen aanvullend onderzoek verricht.

UIT HET DOSSIER
Bron 6, p. 1.

METING	GEMETEN	ALGEMENE REFERENTIE*	METHODE	PIJN
Flexie	40°	50°	actief, 3×, goniometer	eindstandig
Extensie	30°	60°	actief, 3×, goniometer	eindstandig
Rotatie links	50°	80°	actief, 3×, goniometer	eindstandig
Rotatie rechts	60°	80°	actief, 3×, goniometer	geen
Lateroflexie links	25°	45°	actief, 3×, goniometer	geen
Lateroflexie rechts	25°	45°	actief, 3×, goniometer	geen

* Algemene referentiewaarden uitsluitend ter klinische oriëntatie; zij vormen geen zelfstandige AMA-classificatie. Weergegeven is de beste reproduceerbare waarde van drie metingen.

1d

Consistentie

SPECIALIST

Samenhang tussen anamnese, medisch dossier en onderzoeksbevindingen.

Oordeel

Het beloop dat betrokkene beschrijft, komt overeen met de medische informatie. De bevindingen bij onderzoek passen bij de klachten; de bewegingsbeperking was bij herhaling gelijk.

1e

Reactie op inconsistenties

SPECIALIST

Reactie van betrokkene op eventuele inconsistenties.

Oordeel

Niet van toepassing; er zijn geen inconsistenties vastgesteld die met betrokkene moesten worden besproken.

1f

Diagnose

● SPECIALIST

Diagnose en differentiaaldiagnostische overwegingen.

De beschikbare gegevens zijn verenigbaar met een traumatische aggraving van reeds aanwezige degeneratieve afwijkingen. De relatieve bijdrage van het ongeval is niet kwantificeerbaar.

DE SPECIALIST

Diagnose

Chronische nekklachten met uitstraling naar de linker arm na een whiplashtrauma (WAD graad II), bij pre-existente degeneratie C5–C6.

Differentiaaldiagnose

Ik onderscheid: (1) posttraumatische nekklachten zonder aantoonbare nieuwe structurele afwijking; (2) pre-existente, voor het ongeval symptoomloze degeneratie C5–C6; (3) een mogelijke traumatische verergering van die degeneratie; (4) een mogelijke radiculopathie C6 links; (5) een ulnarisneuropathie links, die buiten mijn vakgebied valt.

Conclusie

Er bestaat een temporeel verband tussen het ongeval en het ontstaan van de nekklachten. De beschikbare gegevens zijn verenigbaar met een traumatische aggraving van reeds aanwezige cervicale degeneratieve afwijkingen. De relatieve bijdrage van het ongeval, de degeneratieve afwijkingen en eventuele neurologische problematiek is op basis van de beschikbare informatie niet kwantificeerbaar.

Basis

Vóór het ongeval zijn geen nekklachten gedocumenteerd, terwijl de degeneratie op de CT van de ongevalsdag al zichtbaar was. De klachten ontstonden direct na het ongeval en zijn sindsdien consistent beschreven. Het klachtenpatroon is verenigbaar met cervicale klachten bij de op beeldvorming beschreven afwijkingen op C5–C6; een zelfstandige C6-radiculopathie is hiermee niet aangetoond.

UIT HET DOSSIER

Bron 1, p. 2; bron 3, p. 1–3; bron 6, p. 1.

Onzekerheid

Welk deel van de huidige klachten door het ongeval komt en welk deel door het natuurlijk beloop van de degeneratie, kan ik niet met redelijke zekerheid vaststellen. Ook of er sprake is van een zelfstandige radiculopathie C6 is niet zeker. Het eindverslag van de fysiotherapie zou het beloop in het eerste jaar kunnen verduidelijken.

UIT HET DOSSIER

Zie hiaat 1 en aandachtspunt 1.

Buiten mijn vakgebied

De ulnarisklachten en de cognitieve klachten beoordeel ik niet; daarvoor adviseer ik een neurologische expertise.

UIT HET DOSSIER

Zie aandachtspunten 2 en 3.

1g

Beperkingen

● SPECIALIST

Semi-kwantitatief: geen, licht, matig, ernstig of volledig. Een FML stelt de bedrijfs- of verzekeringsarts op.

Beperkingen op orthopedisch gebied

Betrokkene is orthopedisch gezien matig beperkt voor langdurige statische nekbelasting, repeterende eindstandige nekbewegingen en frequent bovenhands werken. Hij is licht beperkt voor tillen en niet beperkt voor lopen en staan. Voor een arbeidskundige vertaling naar concrete duur- of gewichtsgrenzen is afzonderlijk onderzoek aangewezen.

Basis

De beperkingen volgen uit de bewegingsbeperking en de pijn bij eindstandig bewegen bij onderzoek (1c), en passen bij het klachtenbeloop in het dossier.

Wat dit oordeel niet is

Dit is een medisch oordeel over beperkingen, geen oordeel over arbeidsongeschiktheid of belastbaarheid in het werk. Een FML en de vertaling naar werk zijn aan de bedrijfs- of verzekeringsarts.

1h-k

Medische eindsituatie

● SPECIALIST

Is de situatie geschikt voor beoordeling, of is verbetering of verslechtering te verwachten?

h. Geschikt voor beoordeling

Voor de orthopedische neklachten acht ik de situatie stationair.

i-j. Te verwachten verandering

Gelet op duur en beloop acht ik verdere substantiële verbetering niet waarschijnlijk. Dit oordeel betreft niet de neurologische en cognitieve klachten, die nog onvoldoende zijn gedocumenteerd.

k. Gevolgen voor de beperkingen

Geen verandering verwacht in de beperkingen onder 1g.

1(1) Functieverlies (optioneel)

● SPECIALIST

Percentage functieverlies volgens de AMA Guides en de richtlijnen van de NOV. Dit betreft alleen algemene dagelijkse activiteiten, niet het beroep.

Oordeel

3% functieverlies van de gehele persoon volgens de AMA Guides, 6e druk: klasse 1 voor aspecifieke nekklachten (tabel 17-2), na correctie voor functionele historie, lichamelijk en aanvullend onderzoek.

Basis

De klachten zijn sinds het ongeval herhaald gedocumenteerd. Er zijn radicaire klachten zonder objectiveerbare radiculopathie. Daarom is gekozen voor de rij aspecifieke nekklachten, niet voor de rij met discusafwijkingen en radiculopathie.

UIT HET DOSSIER

Zie 1c, 1f en aandachtspunt 1.

Onzekerheid

De uitkomst is weinig gevoelig voor de functionele historie: met modifier 0 blijft het 3%. Telt het aanvullend onderzoek niet mee, dan is de uitkomst 2 tot 3%.

Wat dit percentage niet is

Functieverlies volgens de AMA Guides zegt iets over beperkingen in algemene dagelijkse activiteiten. Het is geen maat voor arbeidsongeschiktheid of verlies aan verdienvermogen.

2a-b Klachten en beperkingen vóór het ongeval

● SPECIALIST

Onderscheid tussen anamnese en medische broninformatie.

Volgens betrokkene

Geen nek- of armlachten vóór het ongeval.

Volgens de broninformatie

In de huisartsinformatie over de vijf jaar vóór het ongeval zijn geen nek- of schouderklachten gedocumenteerd. De degeneratie C5–C6 bestond wel al; die is op de CT van de ongevalsdag beschreven.

UIT HET DOSSIER

Bron 1, p. 2; bron 3, p. 1–3.

Beperkingen toen en nu door bestaande afwijkingen

Vóór het ongeval zijn geen beperkingen bekend.

2c-d Klachten zonder ongeval

● SPECIALIST

Aanwijzingen en inschatting: waarschijnlijkheid, termijn en omvang.

Aanwijzingen

De degeneratie C5–C6 kan ook zonder ongeval nekkachten geven. Dat klachten na het ongeval voor het eerst zijn gemeld, is op zichzelf geen reden ze volledig aan het ongeval toe te schrijven.

Inschatting

Het is mogelijk dat zonder ongeval op termijn nekkachten waren ontstaan. Waarschijnlijkheid, moment en omvang daarvan zijn niet met redelijke zekerheid te bepalen.

2e-i Beperkingen en verloop zonder ongeval

● SPECIALIST

Semi-kwantitatief, met de verwachte ontwikkeling.

Beperkingen zonder ongeval

Op dit moment waarschijnlijk geen tot licht beperkt.

Te verwachten ontwikkeling

Bij degeneratie van de nek is geleidelijke toename van klachten mogelijk, maar niet voorspelbaar. Een termijn en mate kan ik niet onderbouwd aangeven.

3a

Verdere opmerkingen

SPECIALIST

Relevante bevindingen buiten de vragen en therapeutische suggesties.

Opmerkingen

Voor de ulnarisklachten en de cognitieve klachten adviseer ik een neurologische expertise, met neuropsychologisch onderzoek. Voortzetting van een actief oefenprogramma en ergonomische aanpassing van de werkplek zijn zinvol; van verdere invasieve behandeling verwacht ik weinig.

Procedure en rolverdeling

DOSSIERORDENING

Opdracht	Opdrachtbrief OPDRACHTGEVER , vraagstelling IWMD 2025
Machtiging	Getekende machtiging van betrokkene voor opvragen en gebruik medische gegevens
Dossierordening	Kinetic: ordening, tijdlijn, bronverwijzingen en hiaten, zonder medische duiding
Onderzoek	Anamnese en lichamelijk onderzoek door de specialist zelf
Vorbereiding	Dossierstudie en concept van de medische samenvatting door ARTS , basisarts, onder verantwoordelijkheid van de specialist; de basisarts verricht geen anamnese of lichamelijk onderzoek
Aanwezig bij onderzoek	Betrokkene en de specialist
Verantwoordelijkheid	De specialist is de deskundige; hij draagt de verantwoordelijkheid voor diagnose, beschouwing en conclusies en ondertekent het rapport
Opdrachtgever	Controleert vraagstelling, feitelijke gegevens en volledigheid; niet de medische inhoud
Richtlijn	NVMSR-richtlijn medisch specialistische rapportage 2024

Inzage en blokkeringsrecht

DOSSIERORDENING

Gewezen op recht	Bij het onderzoek, mondeling en schriftelijk
Concept toegezonden	T+29m, met termijn van twee weken

Reactie betrokkene	Correctie van één feitelijke onjuistheid (werkuren); verwerkt in 1a
--------------------	---

Blokkeringsrecht	Na inzage geen gebruik van gemaakt
------------------	------------------------------------

Disclosure statement

 DOSSIERORDENING

Deskundige	Orthopedisch chirurg, BIG BIG-NR ; werkzaam in ORGANISATIE-9
------------	--

Ervaring als deskundige	Ruim twintig jaar orthopedisch chirurg, circa 50 expertises per jaar
-------------------------	--

Nevenfuncties	Geen nevenfuncties met een relatie tot partijen in deze zaak
---------------	--

Belangenconflicten	Geen; geen eerdere behandelrelatie met betrokkene en geen financieel belang bij de uitkomst
--------------------	---

Relatie met de opdrachtgever	In de afgelopen twaalf maanden vier opdrachten van deze opdrachtgever; verhouding eisende en verwerende zijde ongeveer gelijk
------------------------------	---

Ondersteunend arts	De basisarts die het dossier voorbereidde is in dienst van Kinetic; voor hem geldt hetzelfde: geen behandelrelatie met betrokkene en geen belang bij de uitkomst
--------------------	--

Wetenschappelijke discussie	Over de betekenis van degeneratie na een whiplashtrauma bestaan uiteenlopende opvattingen; deze zijn meegewogen in 1f en deel 2
-----------------------------	---

Ondertekening

○ DESKUNDIGE

DESKUNDIGE, ONDERTEKEND

Orthopedisch chirurg · BIG [BIG-NR]

Dossier geordend	Kinetic, case manager CASEMANAGER
Dossierstudie en voorbereiding	ARTS , basisarts, onder verantwoordelijkheid van de specialist
Anamnese en lichamelijk onderzoek	Orthopedisch chirurg, zelf (NVMSR-richtlijn § 7.1)
Beschouwing en conclusies	Orthopedisch chirurg
Ondertekend en eindverantwoordelijk	Orthopedisch chirurg, BIG BIG-NR

Definitief. Ondertekend op T+30m, na controle van vraagstelling en feitelijke gegevens door de opdrachtgever en inzage door betrokkene.



Bronnenlijst

[DOSSIERORDENING](#)

NR.	DOCUMENT	BRON	DATUM	PAG.
1	SEH-verslag met CT-cervicaal	ORGANISATIE-2	T±0	1-2
2	Huisartsbrief	ORGANISATIE-1	T+2w	1
3	Huisartsjournaal	ORGANISATIE-1	T-5j-T±0	1-3
4	Keuringsrapport werkgever	ORGANISATIE-4	T-19m	1
5	Fysiotherapie intake	ORGANISATIE-6	T+4w	1-3
6	MRI cervicale wervelkolom	Radiologie ORGANISATIE-2	T+8m	1
7	Verwijsbrief pijnrevalidatie	ORGANISATIE-7	T+10m	1-2
8	EMG-verslag	Klinische neurofysiologie ORGANISATIE-2	T+13m	1-2
9	Operatieverslag facetdenervatie	Anesthesiologie ORGANISATIE-2	T+14m	1
10	Brief neurologie	Neurologie ORGANISATIE-2	T+15m	1-2
11	Intake cognitieve gedragstherapie	ORGANISATIE-8	T+16m	1-2